



Collection MedWIZ

4^e année médecine

HÉPATO-GASTRO- ENTÉROLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

1. Urgences :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Appendicites aiguë	10				
02	Péritonites aiguës	12				
03	Occlusions intestinales aiguës	14				
04	Ischémies mésentériques	18				
05	Contusions et plaies pénétrantes de l'abdomen	20				
06	Lithiase vésiculaire et ses complications	22				
07	Pancréatites aiguës	26				
08	Lithiase de la voie biliaire principale et ses complications	28				

2. Maladies du foie :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
09	Hépatite chronique	32				
10	Cirrhose	34				

3. Maladies œso-gastro-duodénales :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
11	Gastrites	38				
12	Reflux gastro-œsophagien et ses complications	40				
13	Tuberculose digestive et péritonéale	42				
14	Dyspepsie fonctionnelle	44				
15	Pathologie ano-rectale bénigne	46				
16	Complications des ulcères gastro-duodénaux	50				
17	Hernies diaphragmatiques	52				
18	Hernies pariétales	54				
19	Syndrome de l'intestin irritable (SII)	56				

4. Tumeurs du tube digestif :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
20	Cancer du côlon	60				
21	Cancers primitifs et secondaires du foie	64				
22	Ampullome vaterien	66				
23	Cancer de l'estomac	68				
24	Cancer de l'œsophage et de la jonction œsogastrique	70				
25	Cancer du pancréas	72				
26	Cancer du rectum	74				
27	Cancers des voies biliaires	76				
28	Tumeurs bénignes du foie	78				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
29	Hémorragie digestive haute (HDH)	82				
30	Vomissements	84				
31	Endoscopie digestive	86				
32	Douleur anale	88				
33	Constipation	90				
34	Dysphagie	92				
35	Hémorragie digestive basse (HDB)	94				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

Chapitre I

© 2026 The WIZ The WIZ All rights réservés.

Urgences

© 2026 The WIT Group. All rights reserved.

APPENDICITES AIGUËS

I. DÉFINITION

- Inflammation aiguë de l'appendice vermiculaire.
- Urgence abdominale la plus fréquente, touchant tous les âges avec prédilection chez les 20-30 ans.

II. RAPPEL ANATOMIQUE

- Implanté au bord postéro-interne du cœcum
- Variations de position dans 30% des cas (rétro-cœcal, pelvien, sous-hépatique, méso-coeliaque)

III. PHYSIOPATHOLOGIE

- Obstruction de la lumière (stercolithe, corps étranger, hyperplasie lymphoïde) ou origine hémotogène.

IV. FORMES ANATOMOPATHOLOGIQUES

(gravité croissante)

	FORME	CARACTÉRISTIQUES
1.	Catarrhale	congestive, sans réaction péritonéale
2.	Ulcéreuse	oedématisée, dépôts de fausses membranes, réaction séreuse
3.	Abcédée	collection purulente, adhérences
4.	Gangréneuse	nécrose, perforations fréquentes, exsudat nauséabond

V. DIAGNOSTIC CLINIQUE - FORME TYPIQUE

A. Signes fonctionnels :

- Douleur : épigastrique → FID en quelques heures, lancinante, continue
- Vomissements alimentaires puis bilieux
- Constipation habituelle (diarrhée = forme toxique)

B. Signes généraux :

- Fièvre 38-38,5°C (si >39,5°C → récuser le diagnostic)
- Pouls accéléré, langue saburrale

C. Signes physiques capitaux :

- Douleur à la palpation de la FID (zone douloureuse, pas un point précis)
- Défense pariétale (contracture)
- Heel drop test : douleur abdominale en retombant sur les talons
- Toucher rectal systématique

D. Examens complémentaires :

- NFS : hyperleucocytose avec polynucléose
- Échographie : diamètre >6-8 mm, épaisseur >3 mm
- Scanner : en cas de doute persistant

VI. FORMES CLINIQUES

A. Évolutives :

1. Péritonite purulente généralisée : contracture généralisée, fièvre >39°C, syndrome infectieux sévère
2. Péritonite putride : choc toxique, altération profonde, signes locaux pauvres (pronostic grave)
3. Péritonite localisée / plastron : empatement diffus, traitement médical d'abord, appendicectomie à 3-4 mois
4. Appendicite toxique : état de choc septique, signes locaux discrets (rare, surtout enfant)

B. Topographiques :

1. Rétro-cœcale : douleur lombaire droite, psoïtis, FID libre
2. Pelvienne : douleur sus-pubienne, troubles urinaires/rectaux, douleur au TR à droite
3. Méso-coeliaque : tableau d'occlusion fébrile
4. Sous-hépatique : douleur de l'hypochondre droit (simule cholécystite)

C. Selon le terrain :

1. Femme enceinte : douleur haute ou lombaire, défense moins nette
2. Enfant (<3 ans) : péritonite, diarrhée, déshydratation (diagnostic difficile)
3. Vieillard : occlusion fébrile ou masse FID (évoquer cancer)

VII. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Médical	pathologie pleurale, hépatite, colique néphrétique, angine, entérocolite, adénolymphite mésentériques
Gynécologique	salpingite, kyste ovarien, rupture follicule, GEU
Chirurgical	perforation ulcère, cholécystite, diverticule de Meckel, Crohn

VIII. TRAITEMENT

- Chirurgical exclusif : appendicectomie (coelioscopie ou laparotomie)
- Éviter : lavements, opiacés, antispasmodiques en cas de doute

IX. COMPLICATIONS POSTOPÉRATOIRES

- Abscess de paroi (J6-8) ou du Douglas (J5-10)
- Occlusions postopératoires
- Péritonites postopératoires